BVĐK NHẬT TÂN
Khoa CĐHA-TDCN
Số: 03/QT-CĐHA-TDCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Đốc, ngày 16 tháng 10 năm 2026

QUY TRÌNH SIÊU ÂM VÀ TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH TỪ KHOA LÂM SÀNG ĐẾN BUỒNG SIÊU ÂM KHOA CĐHA-TDCN

(Trình bày dạng lưu đồ – DỰ THẢO, chuyển từ bản giấy đã ký ngày 16/10/2026; nội dung giữ nguyên bản gốc)

I. Mục đích

Bảo đảm người bệnh được tiếp nhận, xác định đúng danh tính, thực hiện siêu âm an toàn, đúng chỉ định và được bàn giao về khoa lâm sàng đầy đủ.

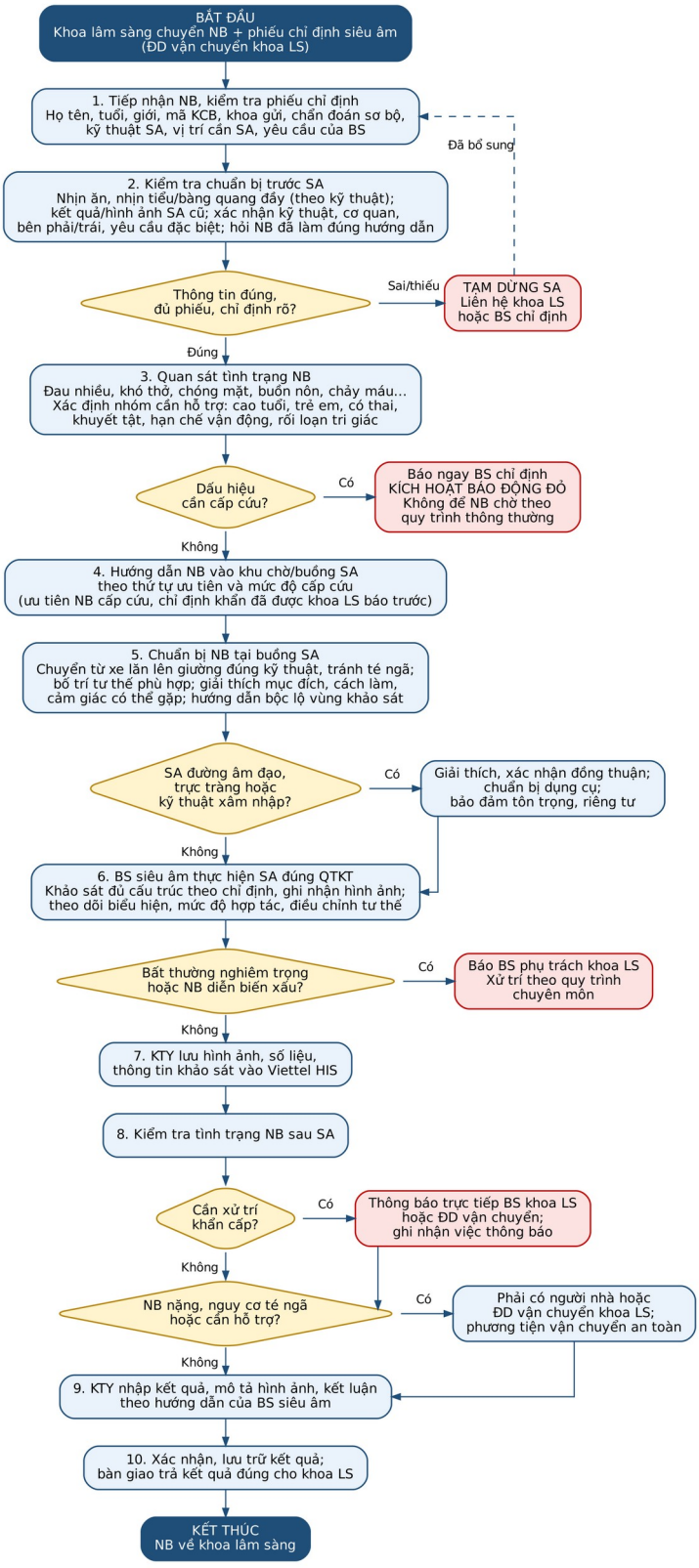
II. Phạm vi áp dụng

Bác sĩ siêu âm, kỹ thuật y siêu âm, bác sĩ và điều dưỡng vận chuyển người bệnh từ khoa lâm sàng.

III. Chữ viết tắt

NB: người bệnh; SA: siêu âm; LS: lâm sàng; BS: bác sĩ; ĐD: điều dưỡng; KTY: kỹ thuật y; KCB: khám bệnh, chữa bệnh; QTKT: quy trình kỹ thuật; HIS: hệ thống thông tin bệnh viện.

IV. Lưu đồ quy trình



Ký hiệu: hình chữ nhật bo góc = bước thực hiện; hình thoi = điểm quyết định; ô đỏ = xử trí khi có bất thường/cấp cứu; mũi tên đứt = quay lại bước trước.

V. Mô tả các bước

Bước	Nội dung	Người thực hiện
Bắt đầu	Khoa lâm sàng chuyển NB đến cùng phiếu chỉ định siêu âm.	ĐD vận chuyển khoa LS

1	Tiếp nhận NB. Kiểm tra phiếu chỉ định: họ tên, tuổi, giới tính, mã KCB, khoa gửi, chẩn đoán sơ bộ, kỹ thuật siêu âm, vị trí cần siêu âm và yêu cầu của bác sĩ.	Nhân viên khoa CĐHA-TDCN (*)
2	Kiểm tra thông tin liên quan: nhịn ăn, nhịn tiểu, bàng quang đầy… (theo kỹ thuật được chỉ định), lịch sử kết quả hoặc hình ảnh siêu âm đã có. Xác nhận kỹ thuật, cơ quan cần khảo sát, bên phải hay trái, yêu cầu đặc biệt. Hỏi NB về việc chuẩn bị trước siêu âm, xác nhận đã làm đúng hướng dẫn của khoa.	Nhân viên khoa CĐHA-TDCN (*)
Quyết định	Sai lệch thông tin, thiếu phiếu chỉ định hoặc chỉ định chưa rõ: tạm dừng siêu âm, liên hệ khoa LS hoặc BS chỉ định; khi đã bổ sung thì làm lại bước 1.	Nhân viên khoa CĐHA-TDCN (*)
3	Quan sát tình trạng NB: đau nhiều, khó thở, chóng mặt, buồn nôn, chảy máu hoặc triệu chứng bất thường khác. Xác định NB thuộc nhóm cần hỗ trợ: người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, hạn chế vận động, rối loạn tri giác.	Nhân viên khoa CĐHA-TDCN (*)
Quyết định	Có triệu chứng bất thường hoặc dấu hiệu cần cấp cứu: báo ngay BS chỉ định, kích hoạt quy trình báo động đỏ của bệnh viện; không để NB tiếp tục chờ theo quy trình thông thường.	Người phát hiện
4	Hướng dẫn NB vào khu vực chờ hoặc buồng siêu âm theo thứ tự ưu tiên và mức độ cấp cứu. Ưu tiên NB cấp cứu hoặc có chỉ định khẩn (khoa LS đã liên hệ trước để chuẩn bị).	Nhân viên khoa CĐHA-TDCN (*)
5	Hỗ trợ chuyển NB từ xe lăn lên giường siêu âm đúng kỹ thuật, an toàn, tránh té ngã. Bố trí, hướng dẫn tư thế phù hợp kỹ thuật, tình trạng bệnh và khả năng chịu đựng. Giải thích mục đích, cách tiến hành, cảm giác có thể gặp. Hướng dẫn bộc lộ vùng cần khảo sát.	KTY siêu âm, ĐD vận chuyển (*)
Quyết định	Siêu âm qua đường âm đạo, trực tràng hoặc kỹ thuật có tính chất xâm nhập: giải thích, xác nhận sự đồng thuận, chuẩn bị dụng cụ, bảo đảm NB được tôn trọng, riêng tư theo quy định.	BS/KTY siêu âm
6	Tiến hành siêu âm đúng quy trình kỹ thuật, khảo sát đầy đủ các cấu trúc theo chỉ định, ghi nhận hình ảnh cần thiết. Theo dõi biểu hiện, mức độ hợp tác của NB suốt quá trình; điều chỉnh tư thế khi cần.	BS siêu âm
Quyết định	Phát hiện dấu hiệu bất thường nghiêm trọng hoặc NB diễn biến xấu: báo BS phụ trách của khoa LS và xử trí theo quy trình chuyên môn.	BS siêu âm
7	Lưu hình ảnh, ghi nhận số liệu và thông tin khảo sát vào phần mềm Viettel HIS.	KTY siêu âm
8	Kiểm tra tình trạng NB sau siêu âm, nhất là NB đau nhiều, NB nặng.	Nhân viên khoa CĐHA-TDCN (*)
Quyết định	Cần xử trí khẩn cấp: thông báo trực tiếp BS khoa LS hoặc ĐD phụ trách vận chuyển, đồng thời ghi nhận việc thông báo theo quy định.	Người phát hiện
Quyết	NB nặng, có nguy cơ té ngã hoặc cần hỗ trợ: phải có	ĐD vận chuyển khoa

định	người nhà hoặc ĐD vận chuyển của khoa LS hỗ trợ và chuẩn bị phương tiện vận chuyển an toàn.	LS
9	Nhập kết quả, mô tả hình ảnh và kết luận theo hướng dẫn của BS siêu âm.	KTY siêu âm
10	Bảo đảm kết quả được xác nhận, lưu trữ và bàn giao trả kết quả đúng cho khoa LS.	BS siêu âm, KTY siêu âm
Kết thúc	NB về khoa lâm sàng.	ĐD vận chuyển khoa LS

(*) Bản gốc chưa ghi rõ người thực hiện bước này; cột này ghi tạm theo phạm vi áp dụng, khoa CĐHA-TDCN xác định lại khi sửa.

VI. Ghi chú rà soát (để khoa bổ sung, sửa ở lần cập nhật)

1. Chưa có mục căn cứ pháp lý. Đề xuất bổ sung: Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; Quyết định 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản áp dụng 2026 – Cần xác minh), tiêu chí D2.4 xác định chính xác người bệnh; Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh của Bộ Y tế (số hiệu quyết định – Cần xác minh).

2. Mục đích nêu "xác định đúng danh tính" nhưng các bước chỉ kiểm tra phiếu chỉ định. Đề xuất thêm bước đối chiếu ít nhất 2 yếu tố nhận dạng (họ tên, năm sinh/mã NB) giữa vòng đeo tay, lời NB và phiếu chỉ định, theo quy định xác định chính xác NB của bệnh viện (hồ sơ D2.4).

3. Phần lớn các bước tiếp nhận (1–5, 8) chưa ghi ai thực hiện (BS hay KTY siêu âm, hay ĐD vận chuyển). Cần phân công rõ.

4. Mục đích nêu NB "được bàn giao về khoa lâm sàng đầy đủ" nhưng bước cuối chỉ bàn giao kết quả; chưa có bước bàn giao NB (ai nhận, ký sổ/ghi nhận ở đâu). Có thể dẫn chiếu Quy trình bàn giao NB giữa các khoa, đơn vị 2026.

5. Chưa có nội dung kiểm soát nhiễm khuẩn: vệ sinh tay, vệ sinh/khử khuẩn đầu dò, bao đầu dò cho siêu âm đường âm đạo, trực tràng.

6. "Quy trình báo động đỏ" và "xử trí theo quy trình chuyên môn": nên ghi số hiệu quy trình nội bộ để tra cứu.

7. Thể thức: chưa có nơi nhận; dùng lẫn "bệnh nhân" và "người bệnh" (nên thống nhất "người bệnh"); "Viettel His" nên ghi "Viettel HIS"; bước nhập kết quả (bước 9) đặt sau bước kiểm tra NB, nên xem lại thứ tự cho đúng thực tế.

GIÁM ĐỐC	**TRƯỞNG KHOA**
(bản gốc đã ký, đóng dấu ngày 16/10/2026)	*(bản gốc đã ký, đóng dấu ngày 16/10/2026)*
TSBS. Châu Hữu Hầu	**BSCKI. Lê Trung Thi**

Người trình bày lưu đồ: CKIĐD. Võ Hồng Thái – Phòng Điều dưỡng